



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : هبة الله نبيل محمد عبدالله
المحافظة : الجيزة
الحى / المدينة : العمرانية
رقم البطاقة : 28608012108285 رقم التليفون : 01110020620
العمر (تاريخ الميلاد) : 01-08-1986 المهنة : ربه منزل
العنوان : 00
تاريخ تسجيل الإستمارة : 07-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج الالم ومضادات القئ لمرضي
الاورام المنتشر [14456]
قسم العلاج :
الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د. / د.

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هبة الله نبيل محمد عبدالله National ID: 28608012108285	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Pin Medication And Anti Emetics
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الاستشارة
طبية
مصر

MDT FORM

3 / 1 / 2023 G

Name	فهد عبد الله بن عبد الله	MRN	٢٨٦.٨.١٩١.٨٩٨
Age	36 v	ID	٤٧٥٥/٢.٢٢
Menopausal status	premen-	Phone	١١٢٢٨٧/١٦٤٥
NRS SCORE		Marital status	married 2 children
BMI		Family history	١١١٥٥٢.٦٢.
CO morbidity	Hx of DVTs, stroke 4 months ago on antiCoagulant (Clexan then marivan)	REASON OF MDT	١٢٧

Clinical Data

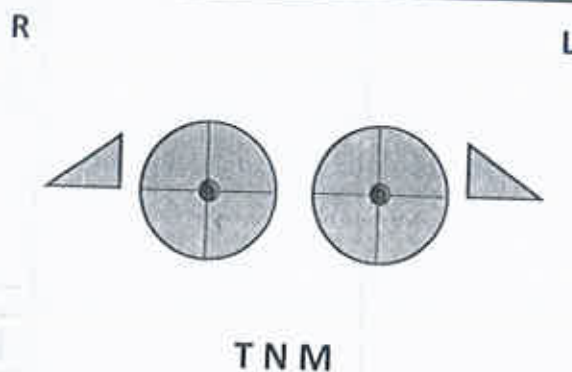
BX: Invasive lobular Carcinoma G II

ER:	PR:	HER 2:	Ki67:
718	718	-ve	15%

Sonomammography:
Rt breast UOP 2.6 x 1.5 BIRADS 4
Lt breast BIRADS 1

Mets Workup:

CTCAP free
bone scan widespread lytic osseous deposit



Recommendations: patient is Denovo Metastatic
(Rt) Breast to bone didn't received any
Treat referred from (Shik Tajed) hospital
To st CDK4/6

MDT OUTCOME & PLAN

Zolodex / Tamoxifen / 2 months + Docetaxel Rth
on chond vertebra

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
SP H 2/4/2023		Rafat 3/1/2023			

SVC-DSH-F-MDT-001
Revision no:0
Issue no:1
Issue date: 3/9/2022

A. y. sh
3/1/2-22

Name: هبه الله نبيل محمد		GUSTAVE ROUSSY	
MR. : 642			
Detailed Medical Report			
			السيد
تحتية طبية وبعد,,			
		إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
		رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته			
تاريخ وساعة الدخول :		تاريخ وساعة الخروج :	
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه			
The patient was initiated on a combined endocrine therapy regimen of zoladex and aramidex, with a plan to add zometa and continue aramidex in the following month, as noted in the internal medicine assessment on 17/02/2026. On 19/04/2026, the medical oncology team documented the patient's metastatic breast cancer to bone, diagnosed in January 2023 as invasive lobular carcinoma (ILC) with ER 7/8, PR 7/8, HER2-negative. The patient was receiving zoladex and arimidex from January 2023, with a recommendation for palliation and radiation therapy to the right hip (D6 to 9) in February 2026. Multiple osseous lesions were identified, and the patient had a history of deep vein thrombosis and dyspnea; a pulmonary angiogram was ordered for evaluation of possible embolic disease. Zometa and arimidex were added to the regimen. The internal medicine note dated 24/05/2026 reported that the patient's metastatic breast cancer remained confined to bone. A brain MRI was performed and was free of disease. The patient continued on aramidex, zoladex, and supportive therapy for a planned duration of three months, with the next clinic visit scheduled for 16/08/2026. In the most recent internal medicine note on 19/07/2026, the patient was seen for arimidex, supportive treatment, and zometa following laboratory evaluation.			
تحريراً في ,			
		التاريخ : 21-09-2026	الوقت :
		هنا أسامه عبد الرحيم عبد البر	الطبيب المعالج :
يعتمد ,			

Patient Name : الأستاذة / هبة الله نبيل محمد عبدالله
Patient No. : 28608012108285
Path No. : SR-936/22
Sex : Female
Age : 36 Y
Referring Doc :

Request No. : 13003650
Request Date : 04/12/2022
Verification Date : 05/12/2022
Financial Category : نفقة الدولة - أورام دار السلام
Department : Out Patient
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:

Right breast mass

Nature of the specimen:

Slide revision

Gross Examination:

1 Block (977) + 3 Slides

Microscopic examination:

- Histological type: Invasive lobular carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: No

Diagnosis:

Right breast mass Slide revision :

- Invasive lobular carcinoma grade II
- CK : Diffuse positive staining
- LCA : Negative
- For IPT (ER- PR- HER2 - KI67)

Prof.Dr.Manal Elmahdy
Dr.Israa Elgendy

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 13/12/2022 09:50:09

Page 1 of 1

Printing By : marwa mc



Patient Name	الأستاذة / هبة الله نبيل محمد عبدالله	Request No.	13003650
Patient No.	28608012108285	Request Date	04/12/2022
Path No.	SR-936/22	Verification Date	17/12/2022
Sex	Female	Financial Category	اورام دار السلام - نفقة الدولة
Age	36 Y	Department	Out Patient
Referring Doc.		Registered by	.marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

- HER2: Negative (score0)
- Ki 67: 15 % nuclear reaction in tumor cells

Prof.Dr.Manal Elmahdy
Dr.Marwa Mahmoud

Verified by :
dr.esraa magdy

Printing Date : 19/12/2022 10:05:46

Page 2 of 2

Printed By : .marwa mohamed youss

Name : heba allah nabil mohamed

Date : 17-02-2026 05:26

Branch : Portable

Medical No. : GRI-

260217172623STD131221107523748902

Ref.Physician Prof : MRI BRAIN+C

Ins.Company :

7ES

MRI OF THE BRAIN

TECHNIQUE:

- Sagittal T2WI
- Axial T1, T2 and FLAIR WI
- Coronal T1WI
- Post contrast T1 WIs

FINDINGS:

- Normal size and parenchymal signal intensity pattern of the cerebral hemispheres, cerebellum and brain stem.
- No intra or extra axial S.O.Ls.
- No areas of pathological enhancement.
- Normal size and configuration of the ventricular system.
- No shift of the midline structures.
- No extra-axial collections.
- Intact cranio-cervical junction.
- Diffuse calvarial bone thickening and low marrow signal.

OPINION:

- Normal contrast enhanced MRI of the brain.
- Diffuse calvarial bone thickening and low marrow signal ? sclerotic for bone scan correlation.

Dr. Maha A. Abdelkarim, MD

Name : Heba allah nabil mohamed

Date : 17-02-2026 01:21

Branch : Portable

Medical No. : GRI-24235

Ref.Physician Prof : cap+c

Ins.Company :

**MULTISLICE POST CONTRAST C.T. EXAMINATION OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS**

In comparison to the last report dated 3-12-2022

I- CHEST:

- Bilateral lower lobar mosaic attenuation is noted (small airway disease)
- No pulmonary nodules, masses or cavitary lesions.
- No consolidation or collapse.
- No hilar or mediastinal masses or lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collection.
- Normal plain CT appearance of the heart and great vessels.
- Unremarkable both breasts

II- ABDOMEN AND PELVIS:

- The liver shows homogenous parenchymal attenuation. No hepatic focal lesion or dilated biliary radicles.
- Both kidneys are normal site, average sized and showing smooth regular cortical outline and preserved parenchymal thickness and function. No stones or back pressure changes.
- Normal C.T appearance of spleen, pancreas, suprarenal glands, aorta and IVC.
- The urinary bladder shows no evidence of gross masses, diverticulae or stones.
- Normal appearance of the pelvic organs with no pelvic masses or collections.
- IUCD is noted in place.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.

III-SURVEYED SKELETON:

Multiple scattered osseous sclerotic lesion at axial and appendicular skeletons

Opinion:

Multiple scattered osseous sclerotic lesion at axial & appendicular skeletons
(metastatic lesions)



Name : Heba Allah Nabil Mohammed Abdallah

Date : 23-02-2026 09:49

Branch : Dokki

Medical No. : 322454

Ref.Physician Prof : Goustav Roussey Egypt

Ins.Company : تعاقد مستشفى

- **Indication:** 39-year-old female with history of breast carcinoma. Evaluation of osseous metastatic disease.
- **Comparison Study:** Prior bone scan dated 07/09/2024 (images unavailable; report reviewed) demonstrated a metastatic superscan pattern.
- **Radioisotope:** Tc-99m MDP
- **Imaging Protocol:** Whole-body planar images (anterior and posterior projections) acquired approximately 2-3 hours post intravenous injection.

FINDINGS:

Compared to the prior study report, the current scan demonstrates:

- **Persistent but less intense superscan pattern**, indicating treatment response.
- **Residual metastatic lesions** involving: scattered dorsolumbar vertebrae, long bones of the upper and lower extremities, sternum, scattered pelvic infiltrates.
- No new suspicious osseous lesions identified.

IMPRESSION:

- **Interval regression** of known metastatic osseous disease (superscan pattern) compared to prior study dated 07/09/2024, consistent with treatment response.
- Residual metastatic lesions persist as described.
- Continued clinical and imaging follow-up recommended as clinically indicated.

Best regards,
Dr. Alaa Nagi, MD
Nuclear Medicine